



Rôle des hormones FSH et LH dans la prédiction des résultats de la récupération spermatique chez les patients atteints d'azoospermie non obstructive



B, Nourine ¹, L, Ounis ¹, A, Zoghmar ².

¹Laboratory of Molecular and Cellular Biology, Mentouri Brothers, University of Constantine I, Constantine, Algeria.

²Ibn Rochd Clinic, Center for Reproductive Medicine, Constantine, Algeria.

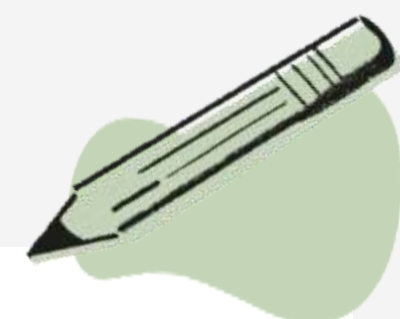


Introduction

L'azoospermie non obstructive (ANO) est caractérisée par une altération de la spermatogenèse et constitue l'une des principales causes d'infertilité masculine sévère. Chez ces patients, la c-TESE représente une approche de référence pour rechercher des spermatozoïdes au niveau du tissu testiculaire. Cependant, le taux de récupération spermatique reste variable et difficile à prédire. Dans ce contexte, les paramètres hormonaux, notamment la FSH et la LH, jouent un rôle important dans la régulation de la fonction testiculaire. Leur dosage pourrait ainsi fournir des informations sur l'activité spermatogénétique et contribuer à identifier les patients ayant une meilleure probabilité de récupération spermatique par c-TESE.

Objectifs

Évaluer l'impact de la FSH et de la LH sur le succès de la récupération spermatique chez les patients atteints d'ANO dans l'Est algérien, afin d'identifier si la FSH et la LH sont des facteurs hormonaux prédictifs des résultats de la c-TESE



Méthodologie

128 patients atteints d'ANO

Ayant réalisé une biopsie testiculaire

Avec paramètres cliniques et hormonaux sériques (FSH, LH).

Les données saisies et analysées à l'aide du logiciel SPSS

Résultats



Une association significative a été retrouvée entre le taux de FSH et le succès de la récupération spermatique ($p = 0,004$).

Une association plus faible avec le résultat de la c-TESE a été observée ($p = 0,05$).

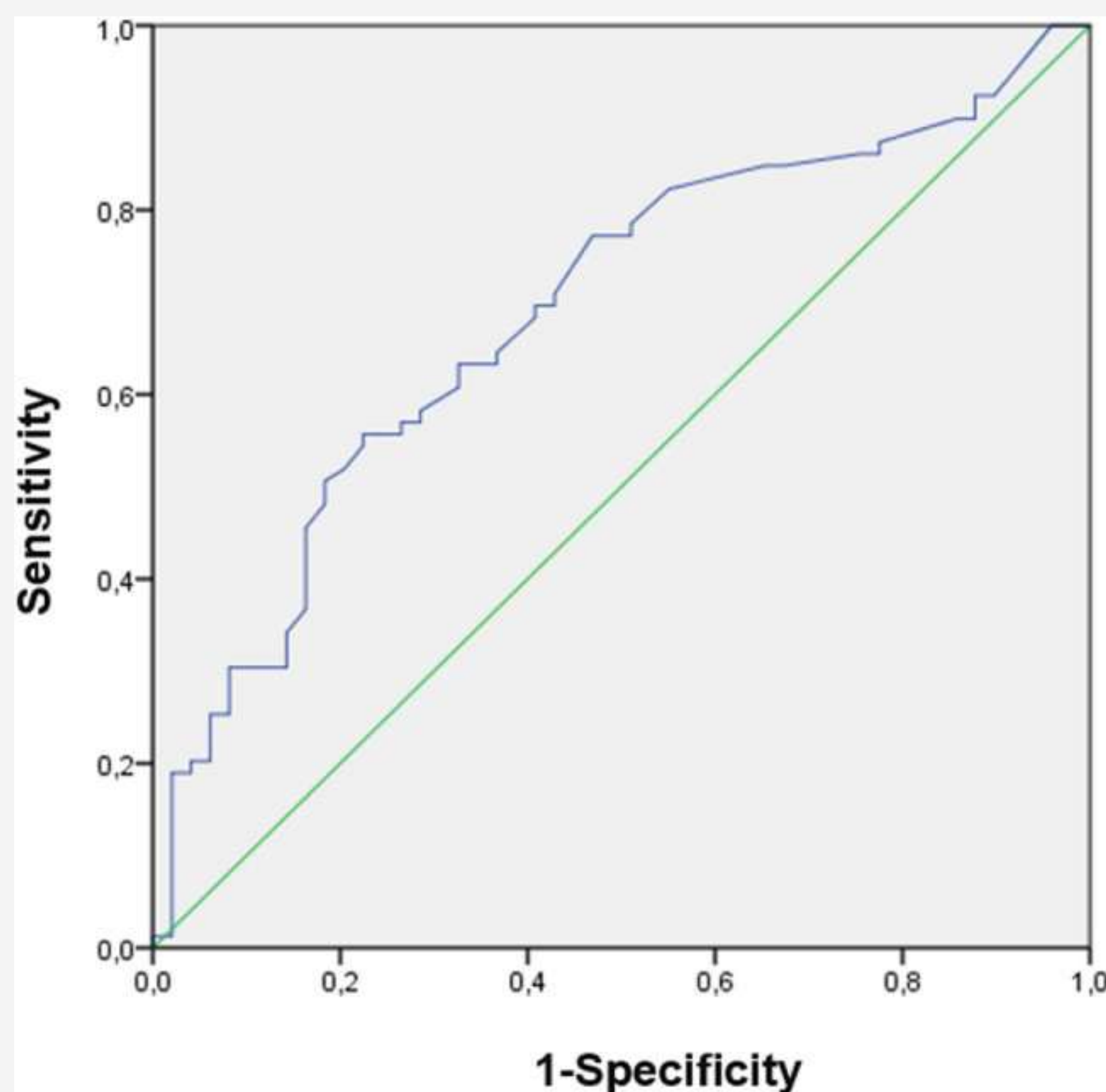


Figure 1- Courbe ROC de la FSH pour prédire le succès de la récupération spermatique

FSH : OR = 0,947 [IC95% : 0,900–0,996], $p = 0,034$

Une augmentation de la FSH est donc associée à une diminution des chances de récupération spermatique.

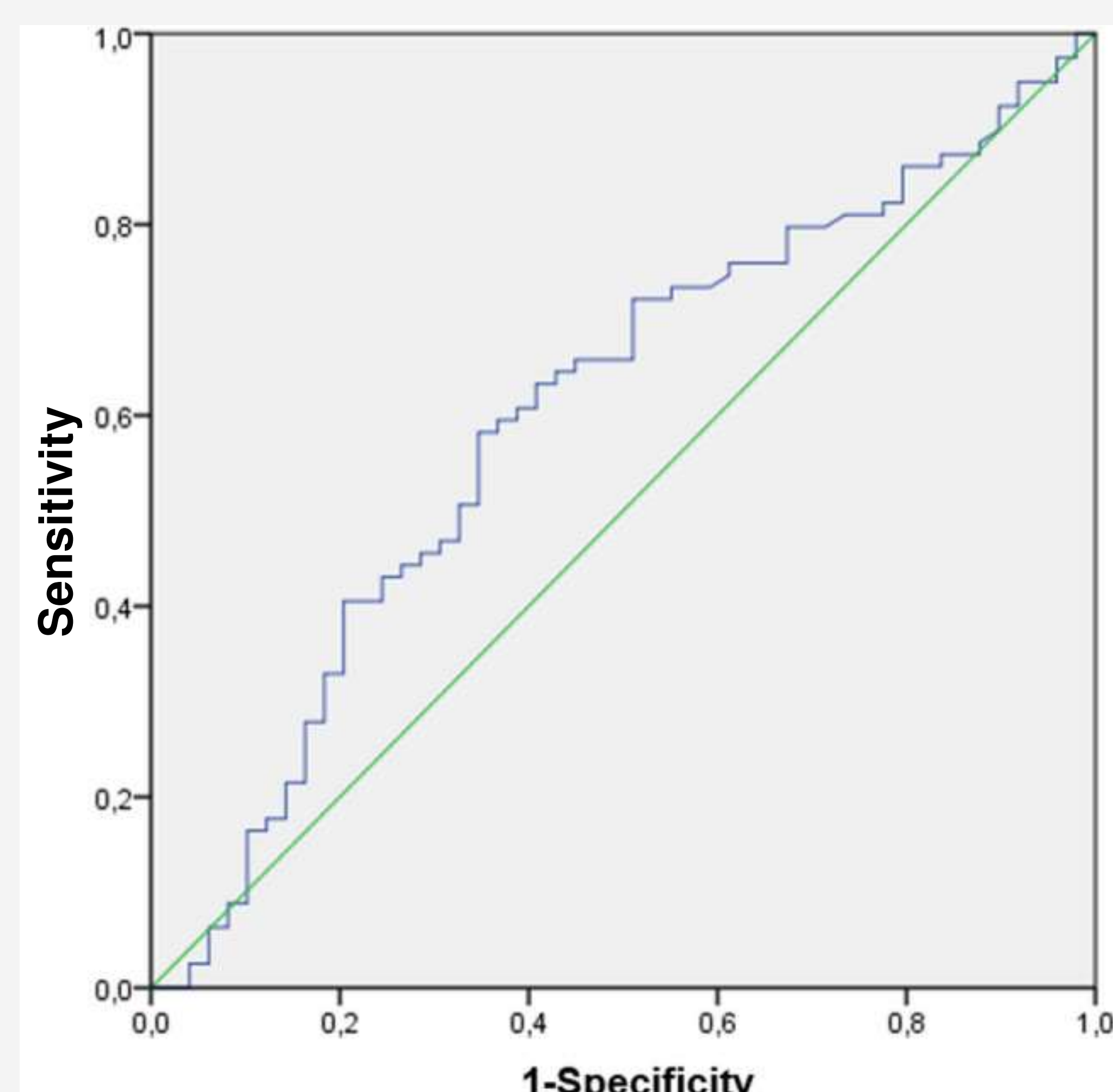


Figure 2- Courbe ROC de la LH pour prédire le succès de la récupération spermatique

LH : OR = 1,069 [IC95% : 1,001–1,142], $p = 0,048$

Une augmentation de la LH est associée à une augmentation des chances de récupération spermatique.

Conclusion

Les résultats de cette étude indiquent que le taux sérique de FSH constitue le principal facteur prédictif indépendant du succès de la récupération spermatique chez les patients algériens atteints d'azoospermie non obstructive ayant bénéficié d'une extraction testiculaire des spermatozoïdes. Par ailleurs, la LH apparaît comme un facteur prédictif de moindre importance comparativement à la FSH et au volume testiculaire. Ces données soulignent l'intérêt de l'évaluation hormonale préopératoire dans l'estimation des chances de récupération spermatique et l'optimisation de la prise en charge des patients atteints d'azoospermie non obstructive.

Références

Nourine, B. H. A., Ounis, L., Hamoul, M., Haddad, F. Z., & Zoghmar, A. (2026). Predictive factors of c-TESE success in eastern Algerian patients with non-obstructive azoospermia: Role of histology, hormones, and testicular volume. Basic and Clinical Andrology, 36(1), 12. <https://doi.org/10.1186/s12610-026-00311-7>